



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : امل مجدي مصطفى كمال
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الهرم
رقم البطاقة : 28602222103083 رقم التليفون : 01279764259
العنوان : -----
العمر (تاريخ الميلاد) : 22-02-1986 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 30-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني + زولاديكس قسم العلاج :
[14165]
الأورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: امل مجدي مصطفى كمال National ID: 28602222103083	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Plus Goserline
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



أهل

مجدى مصطفى كمال متولى

٥٢ ش السبع عمائر - المربوطية - نيفس

الهرم - الجيزة

١٩٨٦/٠٢/٢٢

٢ ٨٦ ٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٠ ٣ ٠ ٨ ٣

IV6499944



٢٠٢١/٠٣

٢٨٦٠٢٢٢١٠٣٠٨٣

حاصلة على ليسانس آداب

قسم تاريخ

متروجة

مسلمة

أنثى

عادل ياقوت سعد بخيت

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٣/٢٣





مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية
صحة
مصر

MDT FORM

416/2025 G

Name	Youssef Mohamed	MRN	01211303803
Age	39	ID	3508/2024
Menopausal status	premen	Phone	01279764259
IRS SCORE		Marital status	married
BMI		Family history	-ve
CO morbidity		REASON OF MDT	postoper

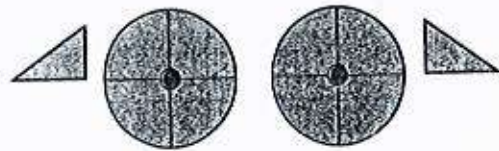
Clinical Data

BX: Post SSM + Abx R

ER: PR: 8/8 HER 2: +3 Ki67: 6/8

Sonomammography: -invasive ductal Ca

Mets Workup: - free Deep, suph-mum
- IN 3/9
- partial Pathol Rem



T N M

Recommendations: 1PT2 IN1

MDT OUTCOME & PLAN

o Port
- Adx 100mg
- Zoladex + Ax

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
M. Kelly	G. El				

Patient Name : الأستاذة / أمل محمد مصطفى كمال متولي
Patient No. : 28602222103083
Path No. : 1243/25
Sex : Female
Age : 39 Y
Referring Doc :

Request No. : 13005551
Request Date : 09/04/2025
Verification Date : 29/04/2025
Financial Category : نفقة الدولة - دور الرعاية
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Left skin sparing mastectomy specimen.

Gross Examination:

- Left skin sparing mastectomy specimen including nipple measured 18x14x3.5 cm. Cut section was ill-defined rubbery to firm beaded greyish white tumor bed site measured 3x2 cm, located retroareolar away 1 cm from superficial margin(not covered by skin), 0.2 cm from nipple. There was a well defined soft to rubbery greyish white nodule measured 1x0.5 cm, located 1 cm from deep margin and away 2.5 cm from the TBS.
SNLs: FFTP measured 4.5x4 cm, entangling 9 LNs up to 1x0.5 cm.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- * Maximal tumour diameter: 3x2 cm, cellularity 10%.
- * Ductal carcinoma in situ: Focal DCIS (comedo type) 5%
- * Perineural invasion: Not detected.
- * Angioinvasion: Not detected.
- * Microcalcifications: Not detected.
- * Additional pathologic findings: The tumour infiltrate the dermis of nipple and areola with free epidermis.
- * Resection Margins: Free superficial and deep margins.
- * Histologic response to therapy: Partial pathological response.
- * Grayish white nodule: Acellular mucin nodule.
- * LNs involvement: positive in (3 / 9)
- * IFT:
- * P63, Calponin: Negative in invasive component.

Verified by :
Dr. Toka Medhat

Printing Date : 08/05/2025 12:22:36

Page 1 of 2

Printing By : manwa mohamed yous

شارقة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

CAP

Patient Name : الأستاذة / أمل مجدى مصطفى كمال متولى
Patient No. : 28602222103083
Path No. : 1243/25
Sex : Female
Age : 39 Y
Referring Doc :
Request No. : 13005551
Request Date : 09/04/2025
Verification Date : 29/04/2025
Financial Category : نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Diagnosis:

- Left breast mass, skin sparing mastectomy specimen.
- Invasive duct carcinoma, G II with focal DCIS and infiltrate the dermis of nipple and areola by the tumor with free epidermis.
- Free deep and superficial margins.
- LNs were positive in (3 / 9).
- Partial pathological response to therapy.
- Stage: ypT2, ypN1.
- RCB: 3.322, RCB class-II.

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar,
Dr. Menna Nabil.

Verified by :
Dr. Toka Medhat

Printing Date : 08/05/2025 12:22:36

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youssef

شارقة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : السيدة / أمل محمد مصطفى كمال مبروك
Patient No. : 28602222103083
Path No. : SR-1519/24
Sex : Female
Age : 38 Y
Referring Doc :
Request No. : 13008224
Request Date : 13/10/2024
Verification Date : 20/10/2024
Financial Category : فئة المرضى - Out Patient
Department : Out Patient
Registered by : Mrs Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer,
Nature of Specimen: Slide Revision

Gross Examination

- 1 paraffin block (892598) and 6 slides were received.

Microscopic Examination

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade II (3+2+1)
- DCIS: Focal.
- Angiolinvasion: No.
- Perineural invasion: No.
- IPT:
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8)
- PR: Strong nuclear reaction in 30% of tumor cells (score 6/8)
- Her2: Moderate complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+).
- Ki67: 25% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis

Left breast cancer, Slide revision.
Invasive duct carcinoma GII with focal DCIS.
IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
 - PR: Positive (score 6/8).
 - Her2: equivocal (score 2+) pending SISH.
 - Ki67: Positive in 25% of tumor cells
- For IPT (SISH).

Signature

Verified by
DR. Menna Nabil

Printing Date: 17/10/2024 10:07:45

Page 1 of 2

Printing By: Hegazy

PATIENT NAME: AMAL MAGDY MOSTAFA KAMAL

GENDER: Female

DATE: 26-Oct-2024 03:12 PM

PATIENT ID: 10124252054

AGE: 38 y

ORDER: 3094536,3095231

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY

INDICATION:

Left breast neoplastic lesion pathologically proven IDC.

TECHNIQUE:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO views
- IV non-ionic contrast medium infusion 100 ml of omnipaque
- Complementary axillary US.

REPORT:

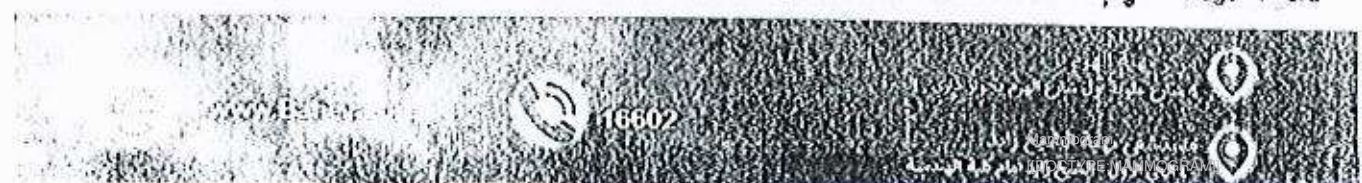
- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed right symmetrical background parenchymal enhancement.
- Left breast LIQ pathological microcalcifications with segmental moderate heterogeneous mass and non enhancement measured 10.5x4.9cm, seen extending anteriorly reaching nipple.
- Left BCQ other faintly enhancing lesions extending over an area that measures 4.7x2.1cm.
- No right breast mass or non mass enhancement.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Left axillary level I solitary subcentimetric lymph nodes with focal increased cortical thickening reaching 4mm with eccentric fatty hilum.
- No pathologically enlarged level II or III lymph nodes.
- Clear supraclavicular region bilaterally.

OPINION:

-Left breast LIQ segmental pathological microcalcifications together with multicentric pathological mass and non mass enhancement as described, pathologically proven IDC (BIRADS 6).

-Solitary level I left axillary indeterminate lymph node.

-No right breast pathological mass or non mass enhancement (BIRADS 1)





Patient Name: Amal Magdy Moustafa Kamal	Date : 17/10/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 38 Year(s)
Medical ID: 3208/2024	Pat. ID: 90839

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS:-

Findings:

↓ Reported case of left breast cancer.

I Chest:-

- The left breast shows heterogenous parenchymal distortion with suspected retro-areolar ill-defined spiculated lesion measuring about 3.7x3 cm in maximum AP and TS dimensions respectively as well as few scattered soft tissue nodules. For sonomammographic correlation. It is seen associated with nipple retraction and thickened overlying skin.
- Prominent left axillary lymph nodes level I and II.
- Prominent left internal mammary lymph node measuring about 4 mm.
- Right apical tiny partially calcified nodule and right lower lobe pleural based nodule, likely of old inflammatory sequel.
- *Otherwise*, Clear both lung fields. No sizable suspicious pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- Apart from subtle right pleural effusion/thickening; No evidence of pleural effusion, thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is seen mildly enlarged with homogenous low parenchymal CT texture. No definite focal lesions (on non contrast base) or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Bulky spleen yet with average parenchymal texture with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes. Retro-aortic left renal vein.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.



Patient Name: Amal Magdy Moustafa Kamal	Date : 17/10/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 38 Year(s)
Medical ID: 3208/2024	Pat. ID: 90839

***Scanned skeleton:**

- Right proximal femur intramedullary expansile lytic lesion noted with sclertic margin for bone scan assessment/ dedicated study.
- Otherwise no definite worrisome lytic or sclerotic focal lesions.

Opinion:

- ! Reported case of left breast cancer showing;
- Left breast heterogenous parenchymal distortion with suspected retro-areolar ill-defined spiculated lesion and surrounding soft tissue nodules, for sonomammographic assessment.
- No evidence of pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.

Dr. Shaimaa Khaled, MSc.

Dr. Walid Mohamed, M.D.

Referring physician: Prof.

^{99m}Tc -MDP BONE SCAN

Desired Information: skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole-body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP.

Report:

- No definite active hot spot that could account for osseous metastatic lesions.
- Abnormal heterogenous radiotracer uptake is seen opposite the spine. Spondylodegenerative changes are seen more pronounced at the mid dorsal vertebrae, and lumbar vertebrae.
- Both kidneys are normally seen.

Conclusion:

No definite hot spot that could account for osseous metastatic lesions.

Thanks for the referral

Nuclear Medicine Unit

DR. Sherin Mahdy, M.D

DR. Mohamed Elmaghrabi